

Douleur au talon

La tendinopathie d'Achille

*Le plan structuré pour soulager le tendon d'Achille
sans arrêter de courir.*



Maxence Lecointe

Ostéopathe D.O. — Expert Running — Lille

Introduction

Pourquoi ce guide ?

Si vous lisez ce guide, c'est probablement parce que votre tendon d'Achille vous freine dans la pratique de la course à pied.

Peut-être que la douleur est présente dès le matin, à la première marche.

Peut-être qu'elle s'atténue paradoxalement pendant la course pour mieux revenir après.

Peut-être que vous avez essayé le repos, les étirements, des semelles — et qu'à chaque reprise la douleur revient.

Et peut-être que vous avez surtout envie d'une chose : courir sereinement.

Qui suis-je ?

Je suis ostéopathe depuis 2015, installé à Lille depuis le début de mon activité. J'ai progressivement orienté ma pratique vers la prise en charge du coureur.

Au fil des années, j'ai accompagné des coureurs débutants, des sportifs en reprise après blessure, des athlètes préparant semi-marathon, marathon ou ultra, ainsi que des profils « sport santé » souhaitant simplement courir sans douleur.

Très vite, une évidence s'est imposée : la majorité des douleurs du coureur ne relèvent pas uniquement d'un trouble local. Elles relèvent souvent d'un déséquilibre entre la charge d'entraînement, la capacité tissulaire, la progression et la récupération.

Ma prise en charge du coureur : une approche globale

Au cabinet, mon accompagnement repose sur cinq piliers :

1. Analyse clinique et compréhension du contexte (historique de blessure, volume d'entraînement, progression récente, objectifs).
2. Évaluation de la charge (répartition hebdomadaire, intensité, variations brutales).
3. Analyse de foulée (observation sur tapis, compréhension des contraintes biomécaniques, mise en perspective sans sur-interprétation).
4. Renforcement ciblé et progressif (travail de capacité musculaire et de tolérance mécanique).
5. Planification du retour à la course (réintroduction structurée des volumes et intensités).

Ce guide est directement inspiré de cette méthodologie. Il ne remplace pas l'accompagnement individualisé, mais il en reprend la logique.

Avez-vous le bon guide ?

Avant de continuer, prenez 2 minutes pour vérifier que ce guide correspond bien à votre situation. Cochez mentalement les affirmations qui vous ressemblent.

Auto-diagnostic en 7 questions

- Ma douleur se situe au niveau du tendon d'Achille (au-dessus du talon, à l'arrière de la cheville).
- La raideur matinale ou au lever d'une longue position assise est un signe que je connais bien.
- Paradoxalement, la douleur diminue souvent pendant la course (effet « warm-up ») mais revient ensuite.
- Elle est apparue après une augmentation de volume, d'intensité, de dénivelé, ou un changement de chaussures.
- Le tendon est sensible à la pression (palpation) — parfois épaissi, parfois douloureux à pincer.
- Le repos seul a déjà été essayé, sans résolution durable.
- Je peux encore courir, ou je veux pouvoir continuer à courir intelligemment.

Si vous cochez 4 affirmations sur 7

Ce guide est probablement adapté à votre situation. La méthode présentée vous donnera un cadre clair pour gérer la douleur, structurer votre reprise, et continuer à courir sans aggraver.

Important : tendinopathie corporéale ou insertionnelle ?

Le tendon d'Achille mesure environ 15 cm. La douleur peut se situer à deux endroits, et le protocole d'exercice varie en conséquence :

Localisation	Distance par rapport au talon	Particularité du plan
Corporéale (midportion)	2 à 6 cm au-dessus du talon	Excentriques avec descente complète sous l'horizontale (protocole standard)
Insertionnelle	Au point d'insertion sur le talon (calcanéum)	Excentriques SANS descente sous l'horizontale (douleur sinon)

Ce guide vous apprend à gérer les deux. La distinction est précisée dans la Partie 3 pour chaque exercice.

Drapeaux rouges : quand consulter sans attendre

La méthode présentée ici suppose une tendinopathie d'Achille « classique ». Certains signes orientent vers d'autres pathologies — en particulier la rupture du tendon — qui nécessitent une évaluation médicale immédiate.

⚠ **CONSULTEZ SANS ATTENDRE SI :**

- Sensation soudaine de « coup de fouet » à l'arrière du mollet, parfois associée à un bruit de claquement.
- Impossibilité de monter sur la pointe du pied, ou faiblesse marquée à la propulsion.
- Douleur très intense (> 7/10) ou qui empire malgré le repos.
- Gonflement net du tendon ou ecchymose visible.
- Douleur nocturne ou présente au repos prolongé.
- Douleur accompagnée de fièvre ou de signes inflammatoires généraux.
- Antécédent de prise de fluoroquinolones (antibiotique) dans les semaines précédant l'apparition de la douleur — risque accru de rupture.

Une rupture du tendon d'Achille est une urgence médicale. Le « test de Thompson » (compression du mollet : si le pied ne fléchit pas, suspicion de rupture) doit faire consulter en urgence.

Dans tous les cas listés ci-dessus, ce guide ne suffit pas. Consultez votre médecin traitant ou un médecin du sport, qui pourra demander une échographie ou une IRM si nécessaire.

Ce que ce guide est, ce qu'il n'est pas

Ce guide est :

- Une base structurée et adaptable.
- Un cadre de progression sur 12 semaines.
- Une synthèse de principes éprouvés en cabinet.
- Un outil pour reprendre le contrôle de votre pratique.

Ce guide n'est pas :

- Un diagnostic médical personnalisé.
- Un protocole universel applicable à tous.
- Un substitut à une consultation.

Chaque coureur est unique. L'âge, l'historique sportif, la morphologie, la charge d'entraînement et les objectifs influencent la prise en charge. Si vous avez un doute, consultez.

À qui s'adresse ce plan ?

Vous êtes au bon endroit si :

- Vous ressentez une douleur au tendon d'Achille à la course ou au lever.
- Vous continuez à courir, ou vous voulez continuer.
- Le repos seul n'a rien réglé durablement.
- Vous êtes perdu(e) entre des conseils contradictoires.

Ce guide n'est PAS fait pour vous si :

- Vous suspectez une rupture du tendon (consultez immédiatement).
- Vous cherchez un diagnostic médical précis.
- Vous refusez d'adapter temporairement votre entraînement.

Principes du plan

10 à 15 minutes par séance. 3 séances par semaine. Sur 12 semaines. En continuant à courir intelligemment.

Partie 1 — Pourquoi ça fait mal et pourquoi ça dure ?

1. Cette douleur est fréquente chez le coureur

La tendinopathie d'Achille touche 5 à 10 % des coureurs sur une saison. Elle se manifeste typiquement par :

- Une douleur localisée au tendon (corporéale ou insertionnelle).
- Une raideur matinale caractéristique : les premiers pas au réveil sont raides, parfois douloureux.
- Un effet « warm-up » : la douleur diminue souvent pendant l'effort et revient après.
- Une apparition après une augmentation de charge, un changement de terrain ou de chaussures.

Bonne nouvelle

Dans la grande majorité des cas, le tendon n'est pas « cassé » ou « usé ». Il est dans un état de surcharge où ses cellules ne savent plus produire un collagène de qualité. Bien chargé, il revient à la normale en quelques mois.

2. La vraie cause : un tendon dépassé par la charge

Le tendon d'Achille est l'un des tendons les plus sollicités du corps humain — il subit jusqu'à 12 fois le poids du corps à chaque foulée.

Quand la charge augmente trop vite, ou trop fort, les cellules du tendon (les ténocytes) ne suivent plus. Le collagène se désorganise, les vaisseaux et les nerfs prolifèrent localement (« néovascularisation »), et la douleur s'installe.

Le problème n'est pas le mouvement. Le problème n'est pas votre foulée. Le problème, c'est un déséquilibre entre :

- la charge imposée (volume, intensité, dénivelé, type de séance),
- la capacité actuelle du tendon à la supporter.

Particularité du tendon

Le tendon s'adapte plus lentement que le muscle. Un muscle peut récupérer en 48 h, le tendon a besoin de 48 à 72 h entre deux séances de charge. C'est pour cela que ce plan dure 12 semaines (vs 8 pour la périostite et 6 pour le syndrome fémoro-patellaire).

3. Pourquoi le repos seul ne règle pas le problème

Beaucoup de coureurs font ceci : douleur → arrêt complet → reprise identique → retour de la douleur.

Le repos diminue l'irritation, mais il ne stimule pas le tendon à se réorganiser. Pire encore, un tendon non sollicité perd encore en capacité — la reprise sera donc plus difficile.

Le but n'est pas d'éviter toute contrainte. Le but est de charger le tendon de façon CONTRÔLÉE pour qu'il se reconstruise un collagène de qualité.

La règle du tendon

Le tendon a besoin de charge pour guérir. Pas n'importe laquelle, pas trop fort, mais régulière. C'est le principe des protocoles excentriques (Alfredson) et de charge lourde lente (Beyer / Heavy Slow Resistance) qui sont les références scientifiques actuelles.

4. Douleur ne signifie pas rupture

Une douleur de 2 ou 3/10 pendant l'exercice ne signifie pas que vous endommagez votre tendon. La douleur est un signal de sensibilité, pas un signal de destruction.

Ce qui compte vraiment :

- Est-ce que la douleur revient à 0 dans les 24 h ?
- Est-ce que la raideur matinale n'augmente pas ?
- Est-ce que la capacité globale s'améliore d'une semaine à l'autre ?

Si oui, vous êtes dans la bonne fenêtre de charge. Si non, ajustez (voir Partie 2).

5. Les erreurs les plus fréquentes

1. Tout arrêter brutalement

Cela soulage temporairement, mais le tendon perd en capacité. La reprise sera plus douloureuse qu'avant.

2. Étirer le tendon en statique sur la douleur

Les étirements passifs intensifs aggravent souvent les tendinopathies, surtout insertionnelles. Préférez le travail dynamique sous charge.

3. Vouloir aller trop vite

Le tendon a besoin de 6 à 12 semaines pour se réorganiser. Brûler les étapes ramène la douleur.

4. Changer trop de variables en même temps

Chaussures + cadence + volume + exercices : impossible de savoir ce qui fonctionne.

Partie 2 — Les règles pour progresser sans aggraver

Avant de commencer le plan d'exercices, il est essentiel de comprendre une chose :

Principe fondamental

Ce n'est pas l'exercice qui guérit. C'est la cohérence dans la gestion de la charge. En respectant ces règles, le tendon progresse. En les ignorant, la douleur revient.

1. La règle de la douleur tolérable

Pendant les exercices ou la course, une gêne légère est acceptable. Une douleur $\leq 3/10$ est généralement tolérable.

On ne veut pas :

- Une douleur qui augmente fortement pendant la séance.
- Une douleur qui explose le lendemain.
- Une raideur matinale qui s'aggrave d'une semaine à l'autre.

Douleur (échelle 0-10)	Conduite à tenir
0–3	Zone acceptable. On continue.
4–6	Prudence. Réduire le volume / l'intensité de la séance.
7+	Stop ou adaptation forte nécessaire.

2. Une seule variable à la fois

Quand l'entraînement évolue, on ne change qu'un seul paramètre : volume, intensité, dénivelé, fréquence ou type de séance.

3. Pas de double progression

On ne peut pas augmenter le volume de course ET la difficulté du renforcement au même moment. On choisit l'un ou l'autre.

4. La règle des 20 %

Si la douleur ou la raideur matinale augmente :

- On réduit le volume hebdomadaire d'environ 20 % de manière temporaire (7 à 14 jours).
- On garde une intensité modérée.
- On supprime temporairement les séances les plus agressives (côtes, fractionné, descentes).

5. La constance prime sur l'intensité

Le tendon répond à la régularité, pas aux séances ponctuelles. 3 séances par semaine pendant 12 semaines battent largement 5 séances la première semaine puis l'abandon.

6. Surveiller les bons indicateurs

Ne pas se focaliser uniquement sur la douleur. Observer aussi :

- La raideur matinale (premier pas au lever) — c'est l'indicateur principal pour le tendon d'Achille.

- Le temps avant que l'effet « warm-up » disparaisse à la course.
- La récupération le lendemain.
- La capacité à monter sur la pointe (force de propulsion).

7. Le principe fondamental

On ne cherche pas à supprimer toute contrainte. On cherche à rendre le tendon plus tolérant à la contrainte.

La progression n'est pas linéaire. Il y aura parfois des jours « avec » et des jours « sans ». Ce qui compte, c'est la tendance sur plusieurs semaines.

À retenir

Une douleur légère contrôlée est acceptable. Une seule variable progresse à la fois. Si la douleur augmente, on ajuste — on ne panique pas. La régularité prime sur l'intensité. La raideur matinale est votre indicateur n°1 : surveillez-la.

Partie 3 — Le plan anti-douleur sur 12 semaines

Pourquoi 12 semaines ? Parce que le tendon est l'un des tissus les plus lents à se réorganiser. Il faut 6 à 12 semaines pour qu'un nouveau collagène de qualité soit produit, et plusieurs mois pour qu'il devienne pleinement fonctionnel. Aller plus vite ne sert à rien.

Le plan suit la progression scientifiquement validée pour les tendinopathies :

1. Semaines 1-4 : phase isométrique (tenir une position) — diminue la douleur, démarre le réveil tissulaire.
2. Semaines 5-8 : phase excentrique (descente lente sous charge) — protocole Alfredson, le standard historique.
3. Semaines 9-12 : phase de charge lourde lente (« Heavy Slow Resistance ») — recherche actuelle, le plus efficace pour la performance.

Avant de commencer

- 10 à 15 minutes par séance.
- 3 fois par semaine.
- Idéalement les jours sans séance de course intense.
- Objectif : restaurer la capacité du tendon à supporter la charge de la course.

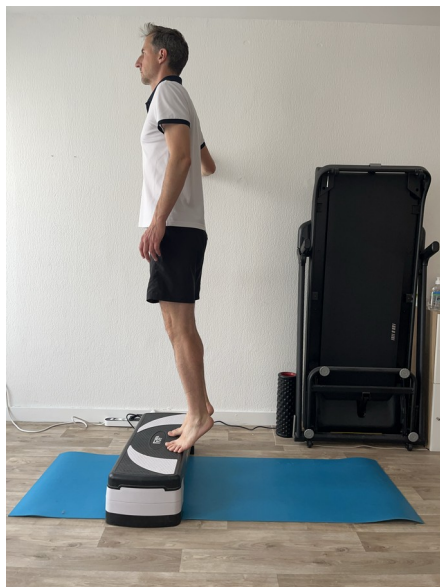
Respecter les règles de la Partie 2 (douleur $\leq 3/10$ à tout moment). Une douleur légère pendant l'exercice est acceptable et même utile au tendon — ce qui compte, c'est l'évolution sur 24 h et la raideur du lendemain matin.

Adaptation insertionnelle

Si votre douleur est insertionnelle (au point d'attache sur le talon), pour TOUS les exercices, ne descendez JAMAIS sous l'horizontale (talon en dessous du niveau de la marche). L'amplitude négative aggrave les tendinopathies insertionnelles.

Exercice 1 — Élévations de talons isométriques (semaines 1-4)

Objectif : déclencher l'effet antalgique des contractions isométriques (jusqu'à 45 minutes de réduction de douleur après une séance bien faite) et démarrer la stimulation du tendon sans amplitude négative.



Démonstration

Mise en place

- Debout, pieds parallèles, largeur du bassin.
- Mains sur un mur ou un dossier de chaise pour l'équilibre.

Exécution

- Monter sur la pointe des pieds (2 secondes).
- MAINTENIR la position haute 30 à 45 secondes — c'est le cœur de l'exercice.
- Redescendre lentement (3 secondes).
- Récupération 1 minute entre les séries.

Erreurs fréquentes

- Ne pas tenir suffisamment longtemps en position haute.
- Tricher en s'appuyant fortement sur les mains.
- Vouloir passer directement à la phase excentrique sans avoir fait l'isométrique.

Progression

Semaines	Séries	Durée tenue	Récupération
1	5	30 sec	1 min
2	5	40 sec	1 min
3-4	5	45 sec	1 min

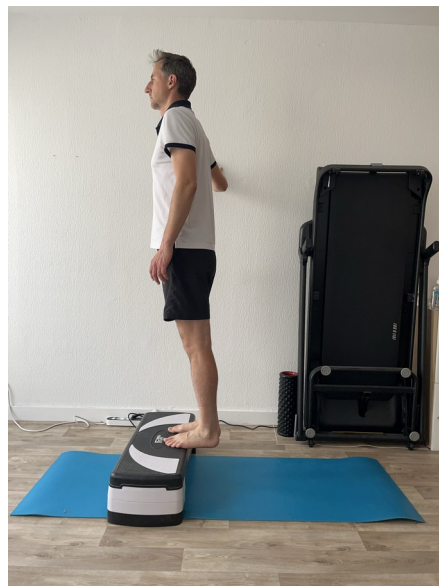
Si la douleur est très forte (>4/10), commencez en bilatéral. Sinon, faites en unilatéral sur la jambe douloureuse.

Exercice 2 — Élévations excentriques (semaines 5-8)

Objectif : protocole Alfredson — la référence historique pour la tendinopathie d'Achille corporéale. La phase de descente lente est ce qui stimule la réorganisation du collagène.



Position de départ



Position basse

Mise en place

- Debout sur une marche, talons dans le vide (avant-pied sur la marche).
- Mains sur un appui pour la sécurité.

Exécution

- Monter avec la jambe NON douloureuse (ou les deux jambes).
- Transférer le poids sur la jambe douloureuse uniquement.
- DESCENDRE LENTEMENT (3 à 5 secondes) jusqu'à ce que le talon passe sous le niveau de la marche (sauf si tendinopathie insertionnelle).
- Remonter avec la jambe non douloureuse (ou les deux).

Erreurs fréquentes

- Descendre trop vite (perte du bénéfice excentrique).
- Laisser les deux jambes faire la descente.
- Pour les tendinopathies insertionnelles : descendre sous l'horizontale (aggravation).

Progression

Semaines	Séries	Répétitions / côté	Genou tendu / fléchi
5	3	10	Genou tendu (gastrocnémien)
6	3 + 1	12 / 12	Genou tendu + 1 série genou fléchi
7	3 + 3	12 / 12	Tendu + Fléchi (soléaire)
8	3 + 3	15 / 15	Tendu + Fléchi

Le genou fléchi cible le soléaire (souvent négligé). Combinez les deux versions à partir de la semaine 6 pour un travail complet.

Exercice 3 — Élévations en charge lourde lente (semaines 9-12)

Objectif : « Heavy Slow Resistance » — la méthode actuellement la plus efficace selon la recherche pour restaurer pleinement le tendon. Ajout de charge externe (sac à dos lesté ou haltères).



Avec sac à dos lesté

Mise en place

- Debout sur une marche, avant-pied sur la marche, talons dans le vide.
- Sac à dos lesté de 5 à 15 kg, ou haltères dans les mains.
- Mains sur un appui pour la sécurité (si haltères : tenir sur les côtés).

Exécution

- Monter LENTEMENT (3 secondes).
- Pause haute 1 seconde.
- Descendre LENTEMENT (3 secondes), jusqu'au niveau de la marche (corporéale : sous le niveau ; insertionnelle : pas en dessous).
- Pause basse 1 seconde, puis remonter.

Erreurs fréquentes

- Charge trop faible (le tendon a besoin de stimulus).
- Tempo trop rapide (perd l'effet « slow »).
- Démarrer trop tôt (avant d'avoir fait les phases isométrique et excentrique).

Progression

Semaines	Séries	Répétitions	Charge
9	3	8	5-7 kg
10	3	10	7-10 kg
11	4	8	10-12 kg
12	4	10	12-15 kg

Adaptez la charge à votre niveau. Le bon repère : la dernière répétition doit être difficile à tenir avec le tempo lent. Si trop facile, augmentez. Si la douleur dépasse 3/10, réduisez.

Exercice 4 — Élévations soléaire (toutes phases)

Objectif : cibler spécifiquement le soléaire — muscle profond du mollet souvent négligé, qui est l'amortisseur principal du tendon d'Achille à la course. À intégrer dès la semaine 1, en complément des autres exercices.



Position assise, genoux fléchis

Mise en place

- Assis sur une chaise, pieds à plat au sol, genoux fléchis à 90°.
- Une charge sur les genoux (sac lesté, haltères, ou simplement les mains).

Exécution

- Monter sur la pointe des pieds (2 secondes).
- Pause haute 1 seconde.
- Descendre lentement (3 secondes).

Erreurs fréquentes

- Ne pas charger suffisamment (le soléaire est très puissant).
- Compenser avec les hanches en se penchant en avant.

Progression

Semaines	Séries	Répétitions	Charge
1-2	3	12	Sans charge
3-4	3	15	5 kg sur les genoux
5-8	3	15	10 kg sur les genoux
9-12	4	12	15 kg sur les genoux

Récapitulatif du plan complet

Phase	Sem.	Ex. principal	Ex. complémentaire (soléaire)
Isométrique	1-4	Maintien position haute 30-45 sec × 5	Élévations soléaire (sans / 5 kg)
Excentrique	5-6	Excentriques talon dans le vide × 10-12	Soléaire 10 kg
Excentrique	7-8	Excentriques tendu + fléchi × 12-15	Soléaire 10 kg
Charge lourde	9-10	Elévations talons lentes 3 × 8-10 (5-10 kg)	Soléaire 15 kg
Charge lourde	11-12	Elévations talons lentes 4 × 8-10 (10-15 kg)	Soléaire 15 kg

3 séances par semaine — 10 à 15 minutes — douleur ≤ 3/10 à tout moment.

La course pendant les 12 semaines

La course n'est pas interdite. L'objectif est de la pratiquer intelligemment, en respectant la fenêtre de tolérance du tendon.

Phase 1 — Stabilisation (semaines 1-4)

Réduire le volume de ~ 20-30 %. Pas de fractionné, pas de côtes, pas de descentes prolongées. Terrain souple privilégié.

Phase 2 — Reprise progressive (semaines 5-8)

Réintroduire doucement le volume habituel. Une seule augmentation à la fois (volume OU intensité, pas les deux).

Phase 3 — Consolidation (semaines 9-12)

Volume normal. Réintroduction prudente des séances d'intensité (côtes courtes, fractionné modéré). Surveiller la raideur matinale.

Au-delà de la semaine 12

Conserver 1 à 2 séances de renforcement du mollet par semaine pendant plusieurs mois. Le tendon a besoin de cette stimulation pour rester solide.

Conclusion : reconstruire pour durer

La tendinopathie d'Achille n'est pas une fatalité. C'est le signe que votre tendon a besoin d'un peu de temps pour se réorganiser et retrouver sa capacité à supporter la course.

La solution n'était pas d'arrêter définitivement. Ni de forcer. Ni d'enchaîner les étirements. Ni de chercher un exercice miracle.

La solution était de comprendre, structurer, progresser — avec patience.

Vous disposez maintenant :

- D'une compréhension claire de la tendinopathie d'Achille (corporéale et insertionnelle).
- Des règles pour éviter d'entretenir la douleur.
- D'un plan d'exercices progressif sur 12 semaines (isométrique → excentrique → charge lourde lente).
- D'une stratégie pour continuer à courir intelligemment.

Ce n'est pas un protocole figé. C'est un cadre adaptable.

Ce qui fera la différence

La régularité et la patience. Le tendon est un tissu lent : il faut lui laisser 12 semaines pour se réorganiser, et plusieurs mois ensuite pour qu'il redevienne pleinement fonctionnel. Trois séances par semaine, sans saut d'étape — c'est ainsi que la capacité revient.

Une vérité importante

La douleur peut fluctuer. La raideur matinale aussi. Un jour meilleur, un jour plus sensible. Ce n'est pas un échec, c'est le processus.

L'objectif n'est pas zéro sensation. L'objectif est une capacité durable.

Pour aller plus loin



Mot de l'auteur

Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez décidé de ne plus subir. Et c'est déjà un premier pas important.

La douleur d'Achille peut être particulièrement frustrante. Elle s'installe insidieusement, elle ne lâche pas facilement, et elle a la mauvaise habitude de revenir au pire moment — souvent à 3-4 semaines d'une course importante.

Dans mon activité d'ostéopathe, j'ai accompagné de nombreux coureurs avec une tendinopathie d'Achille, des coureurs débutants comme des marathoniens confirmés. Tous avaient en commun la même question : « est-ce que je vais pouvoir recourir comme avant ? »

La réponse est presque toujours oui — à condition d'une méthode et d'un peu de patience.

Pour un bilan personnalisé

→ **Réservez votre rendez-vous en cabinet à Lille**

Pour un bilan personnalisé : analyse de foulée, palpation du tendon, identification du type (corporéale ou insertionnelle), plan de reprise individualisé.

doctolib.fr/osteopathe/lille/maxence-lecointe

Cabinet : 40 rue Royale, 59800 Lille.

Témoignage

Baptiste

« En tant que coureur à pied (trail, ultra distance), J'ai à cœur de réaliser un bilan régulier auprès de professionnels qualifiés.

Maxence Lecointe est un super ostéopathe que je consulte depuis plusieurs années (1x/an en fin de saison sportive) et que je recommande totalement. N'hésitez pas, surtout si vous êtes sportif (coureur, cycliste, etc...) Il sera vous aiguiller. » — Baptiste, 30 ans.

Me contacter

- Cabinet : 40 rue Royale, 59800 Lille.
- Itinéraire : maps.app.goo.gl/REedwh2ijmQuvf5C8
- Prise de rendez-vous : doctolib.fr/osteopathe/lille/maxence-lecointe

En cadeau : votre check-list de reprise

Pour vous accompagner au-delà de ce guide, je vous offre une check-list imprimable d'une page à glisser dans votre carnet d'entraînement. Elle reprend les indicateurs à surveiller chaque semaine pour ajuster votre progression.

□ [Télécharger ma check-list gratuite \(PDF\)](#)

Bon courage, et bonne course.